

DOR TORÁCICA



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

RESUMO

É a 2ª queixa mais comum nos cenários de emergência.

Apresenta amplo espectro clínico, sendo fundamental identificar as etiologias potencialmente fatais.

Diagnósticos diferenciais mais relevantes:

- Síndrome coronariana aguda (SCA).
- Tamponamento cardíaco.
- Dissecção aguda da aorta.
- Embolia pulmonar.
- Pneumotórax hipertensivo.



RESUMO

- **Como avaliar:**

História clínica + exame físico + ECG (realizado e interpretado em até 10 minutos da admissão) + dosagem de marcador de necrose miocárdica.

- **História clínica:**

Tabela 1.4 – Classificação de angina proposta pelos investigadores do estudo CASS	
Dor definitivamente anginosa	Dor retroesternal precipitada por esforço com irradiação para ombro, pescoço ou braço esquerdo e atenuada por repouso ou nitrato em menos de 10min
Dor provavelmente anginosa	Apresenta a maioria das características da dor definitivamente anginosa
Dor provavelmente não anginosa	Dor de característica atípica que não preenche critérios para dor anginosa
Dor definitivamente não anginosa	Dor sem correlação com atividade física, sugere ser de origem extracardiaca e não é atenuada por nitratos

Fonte: Adaptada de National Heart Lung and Blood Institute Coronary Artery Study.²²

Tabela retirada de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021.



RESUMO

- **Escore HEART:**

Prediz a probabilidade de eventos cardiovasculares maiores em 6 semanas.

Tabela 14 – Escore HEART

Escore HEART	
História	2 = altamente suspeita
	1 = moderadamente suspeita
	0 = pouco/nada suspeita
Eletrocardiograma	2 = depressão significativa do segmento ST
	1 = distúrbios de repolarização inespecíficos
	0 = normal
Anos (idade)	2 = ≥ 65 anos
	1 = ≥ 45 anos e < 65 anos
	0 = < 45 anos
Risco (fatores*)	2 = ≥ 3 ou história de doença aterosclerótica
	1 = 1 ou 2
	0 = nenhum
Troponina (convencional)**	2 = $\geq 3x$ o limite superior
	1 = 1 – $3x$ o limite superior
	0 = $\leq$ limite superior

ECG: eletrocardiograma. *Fatores de risco: Hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade (IMC >30 kg/m²), tabagismo (atual ou cessação do tabagismo ≤ 3 meses), histórico familiar positivo precoce (primeiro grau). ** O escore HEART original utilizou troponina convencional; a sua versão modificada para troponina de alta sensibilidade, baseia-se no escore HEART (História, Anos/Idade, Eletrocardiograma, Risco) e utiliza também pontos de corte específicos dos algoritmos de troponina de alta sensibilidade.



RESUMO

- **Escore HEART:**

Escore HEART

História

2 pontos: altamente suspeita
1 ponto: moderadamente suspeita
Nenhum ponto: pouco/nada suspeita

ECG

2 pontos: depressão significativa do segmento ST
1 ponto: distúrbios de repolarização inespecíficos
Nenhum ponto: pouco/nada suspeita

Anos (idade)

2 pontos: ≥ 65 anos
1 ponto: ≥ 45 anos e < 65 anos
Nenhum ponto: < 45 anos

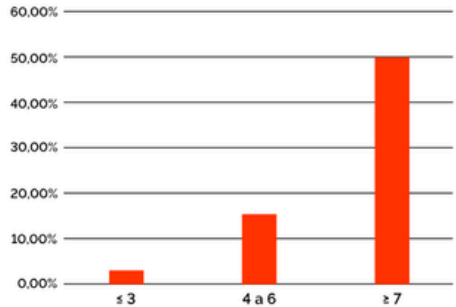
Risco (fatores *)

2 pontos: ≥ 3 ou história de doença aterosclerótica
1 ponto: 1 ou 2
Nenhum ponto: nenhum

Troponina

2 pontos: ≥ 3 x o limite superior
1 ponto: 1 - 3 x o limite superior
Nenhum ponto: $\leq$ limite superior

Eventos cardiovasculares maiores em 6 semanas



Baixo risco = Escore HEART ≤ 3 pontos

* hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, obesidade (IMC > 30 Kg/m²), tabagismo (atual ou interrupção há 3 meses), história familiar de DAC precoce

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST-2021. Rio de Janeiro: Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2021.



ROTINA CLÍNICA

RESUMO

Interpretação:

- **Baixo risco (Escore HEART < 4):**
Acompanhamento ambulatorial
- **Risco Intermediário (Escore HEART 4 a 6):** Estratificação não invasiva (ecocardiograma de estresse, teste ergométrico, angiotomografia das artérias coronárias).
- **Alto risco (Escore HEART ≥ 7):**
Cateterismo cardíaco precoce em até 24 horas.



RESUMO

Muito alto risco: Abordagem invasiva imediata (< 2 horas).

Caracterizado pela presença de:

- Instabilidade hemodinâmica.
- Choque cardiogênico.
- Dor torácica refratária ao tratamento medicamentoso.
- Arritmias malignas.
- PCR.
- Insuficiência cardíaca aguda.
- Alterações recorrentes do segmento ST com elevação intermitente do segmento ST.



RESUMO

Síndrome coronariana aguda (SCA)

- **Angina Instável:**

Definição: eletrocardiograma sem critérios para supradesnivelamento do segmento ST + troponina negativa.

Estratificação coronariana não invasiva: escore HEART > 3.

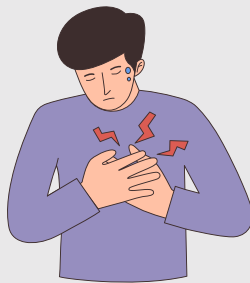


RESUMO

- **Infarto sem supra de ST:**

Definição: eletrocardiograma sem critérios para supradesnivelamento do segmento ST + troponina positiva.

Detalhe: devemos sempre realizar a estratificação invasiva nesses pacientes.



RESUMO

Quando repetir a troponina?

- **Troponina ultrassensível:**

Pode ser realizada entre 1 a 2 horas após a 1ª dosagem (0 - 1 ou 2).

- **Troponina convencional:**

Pode ser realizada entre 3 a 6 horas após a 1ª dosagem (0-3-6).

- **Quando repetir o ECG?**

Em caso de recorrência de dor torácica após analgesia ou pelo menos 1 vez em até 6 horas.



ABORDAGEM

Ofertar oxigênio: cateter nasal com 2 a 4 L/min para manter saturação periférica de oxigênio > 90-94%.

Controle álgico: nitrato oral ou endovenoso.

Racional: reduzem o retorno venoso sistêmico e a congestão pulmonar; promovem vasodilatação coronária com aumento da circulação colateral e auxiliam na inibição da agregação plaquetária*.



ABORDAGEM

Como utilizar os nitratos:

Utilizar, inicialmente (se possível), nitrato por **via sublingual**. Podemos utilizar o Mononitrato de isossorbida na dose de 5 mg.

Se indicado nitrato EV, devemos utilizar a nitroglicerina (Tridil®):

Iniciamos na dose de $10\mu\text{g}/\text{min}$ com incrementos de $10\mu\text{g}$ a cada 5 minutos.

Objetivos: melhora da dor, redução da congestão pulmonar e/ou redução da pressão arterial.



ROTINA CLÍNICA

ABORDAGEM

Contraindicações ao uso dos nitratos:

- Infarto de VD - Avaliar: supra de ST em parede inferior e em V3R e V4R.
- Hipotensão arterial importante (pressão arterial sistólica $< 100\text{mmHg}$).
- Uso de sildenafil nas últimas 24h ou uso de tadalafila nas últimas 48h.



ABORDAGEM

Antiagregação plaquetária:

Angina instável ou IAM sem supra de ST: prescrever 300 mg de AAS (03 comprimidos).

NÃO UTILIZAR clopidogrel de rotina nestas situações!!

OBSERVAÇÃO: utilizar clopidogrel 300 mg **APENAS SE NÃO** houver possibilidade de realizar cateterismo coronariano em até 24h.



ROTINA CLÍNICA

ABORDAGEM

IAM com supra de ST:

Em locais onde há disponibilidade de transferência (CATE) de urgência: administrar **300 mg de AAS + 600 mg de Clopidogrel**.

Atenção: Em caso de trombólise, devemos administrar 300 mg de clopidogrel. Nos pacientes acima de 75 anos, a dose de clopidogrel deve ser de apenas 75 mg.

Demais detalhes estão disponíveis no guia de prescrição!



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Diretrizes da SBC sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021.
- Livro de Medicina de Emergência FMUSP – 15ª Edição.
- Avaliação do adulto com dor torácica no serviço de urgência – UpToDate.

